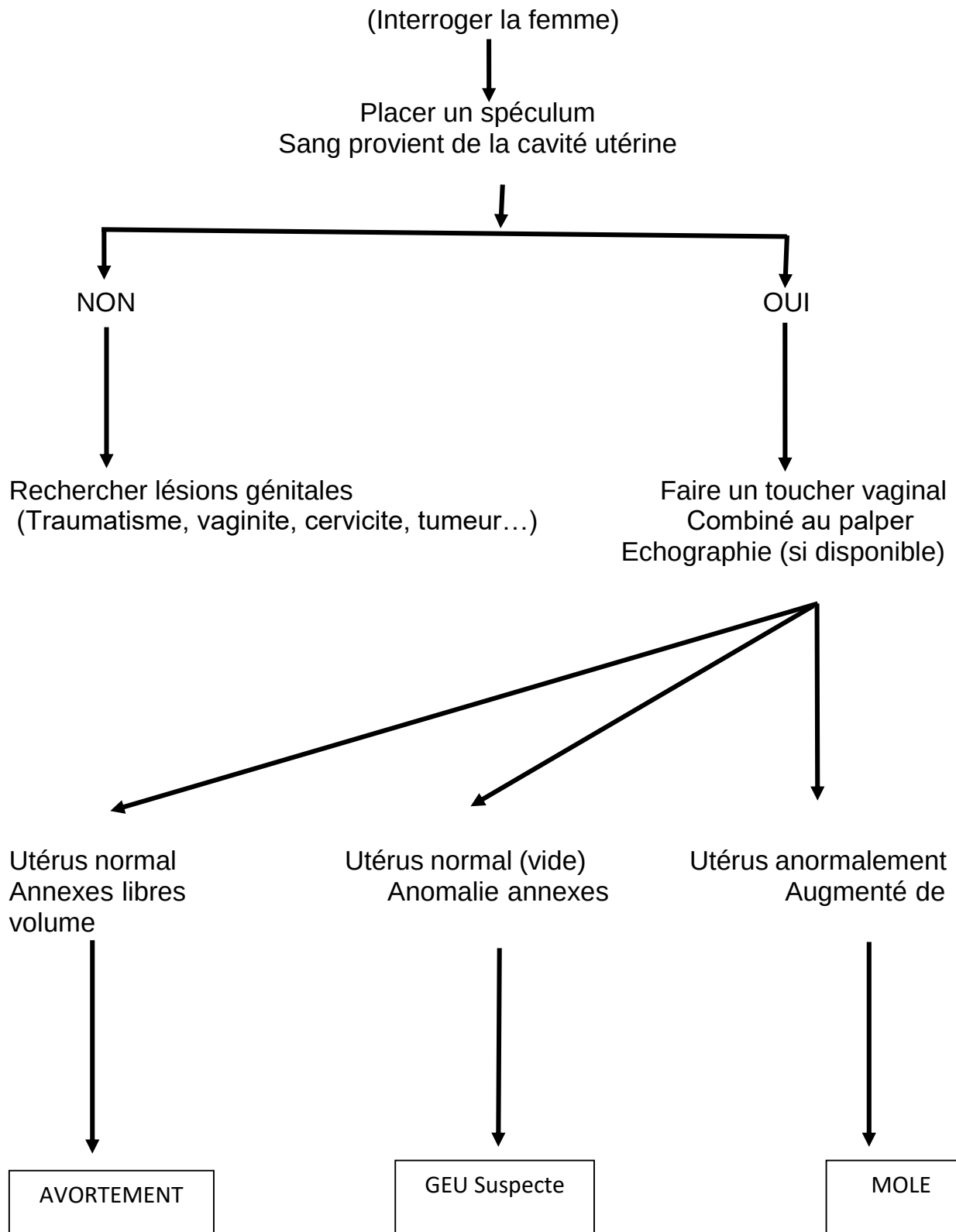


DIAGNOSTIC DE L'HEMORRAGIE DE DEBUT DE GROSSESSE



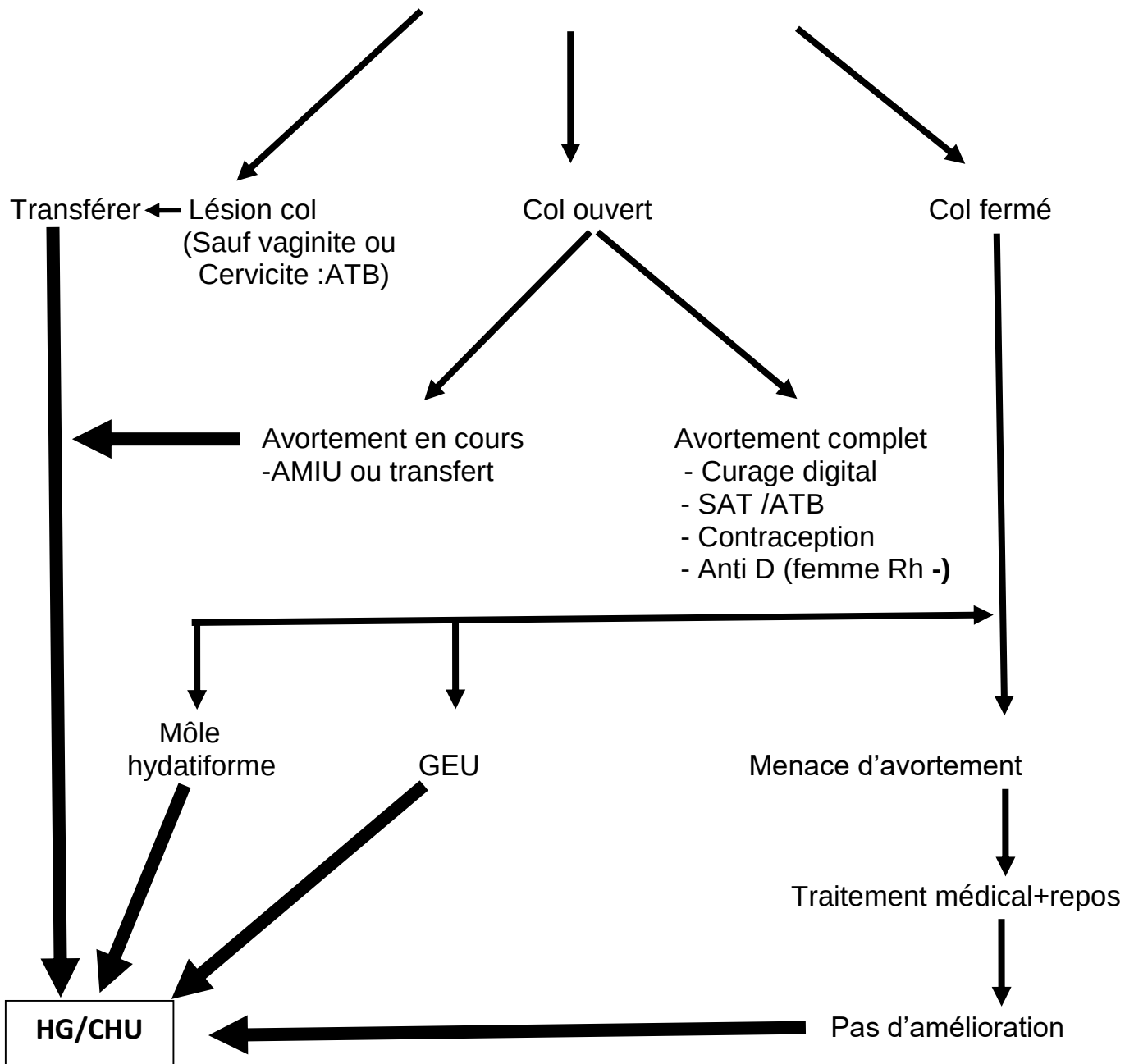
CAT DEVANT UNE HEMORRAGIE DE DEBUT DE GROSSESSE

EVALUER L'ETAT DE GRAVITE DE LA PATIENTE (bilan initial)

Mettre en condition/Interroger/Examiner
Préciser : TA, pouls, état de conscience

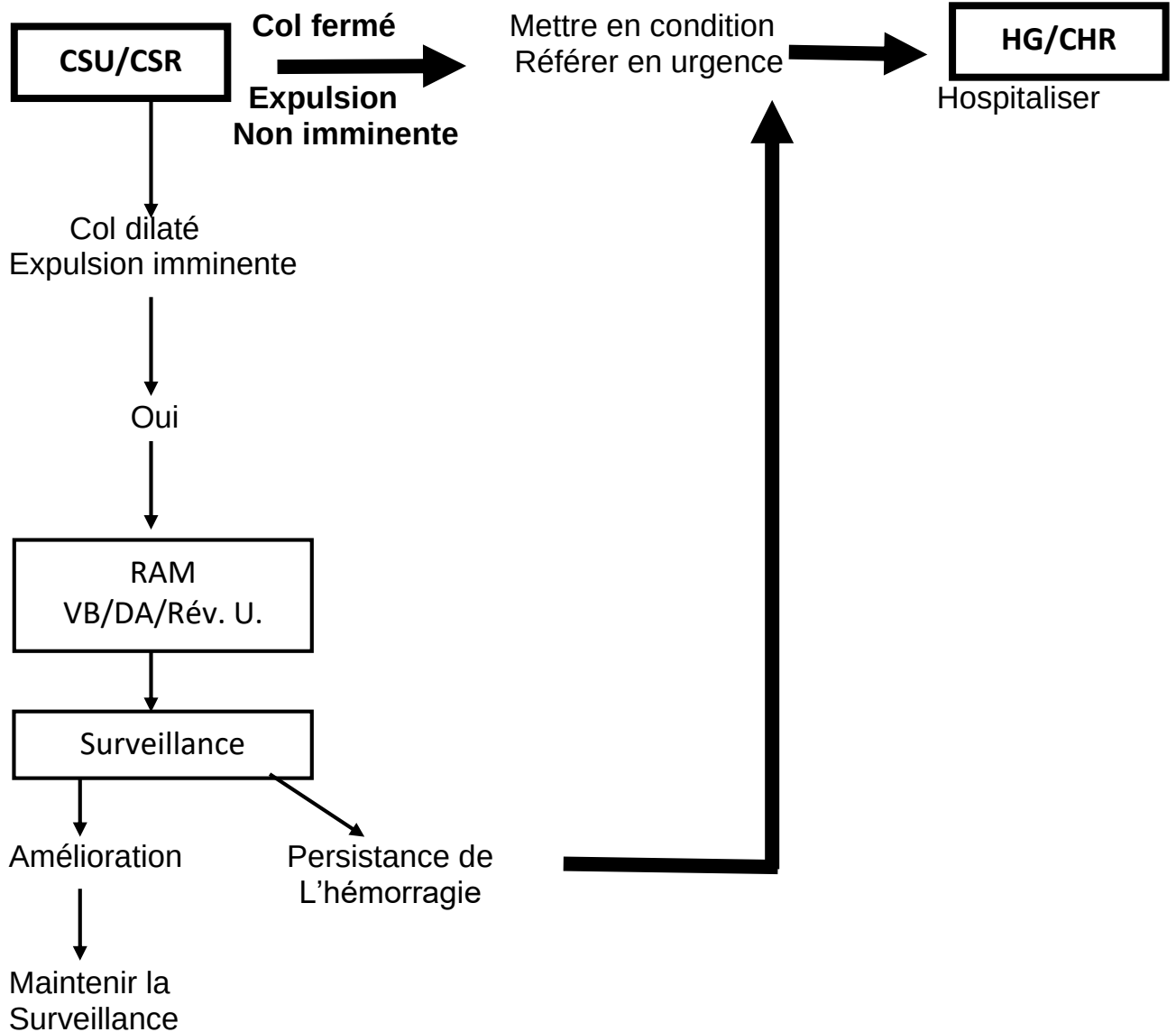
CSU/CSR

(Préciser l'état du col au toucher vaginal)



NB : Ces algorithmes pratiques concernent surtout les formes typiques du diagnostic clinique

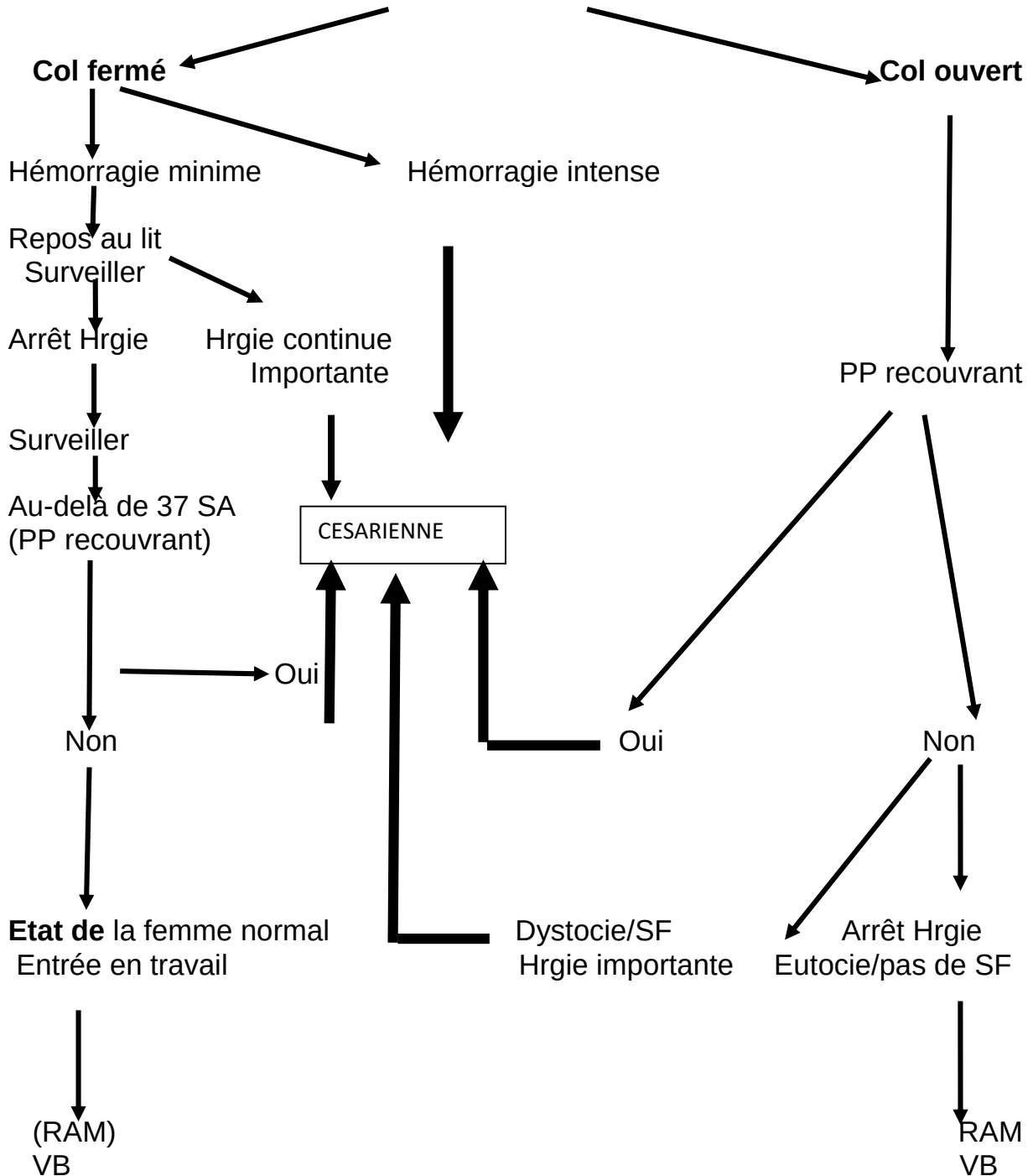
CAT DEVANT UN PLACENTA PRAEVIA



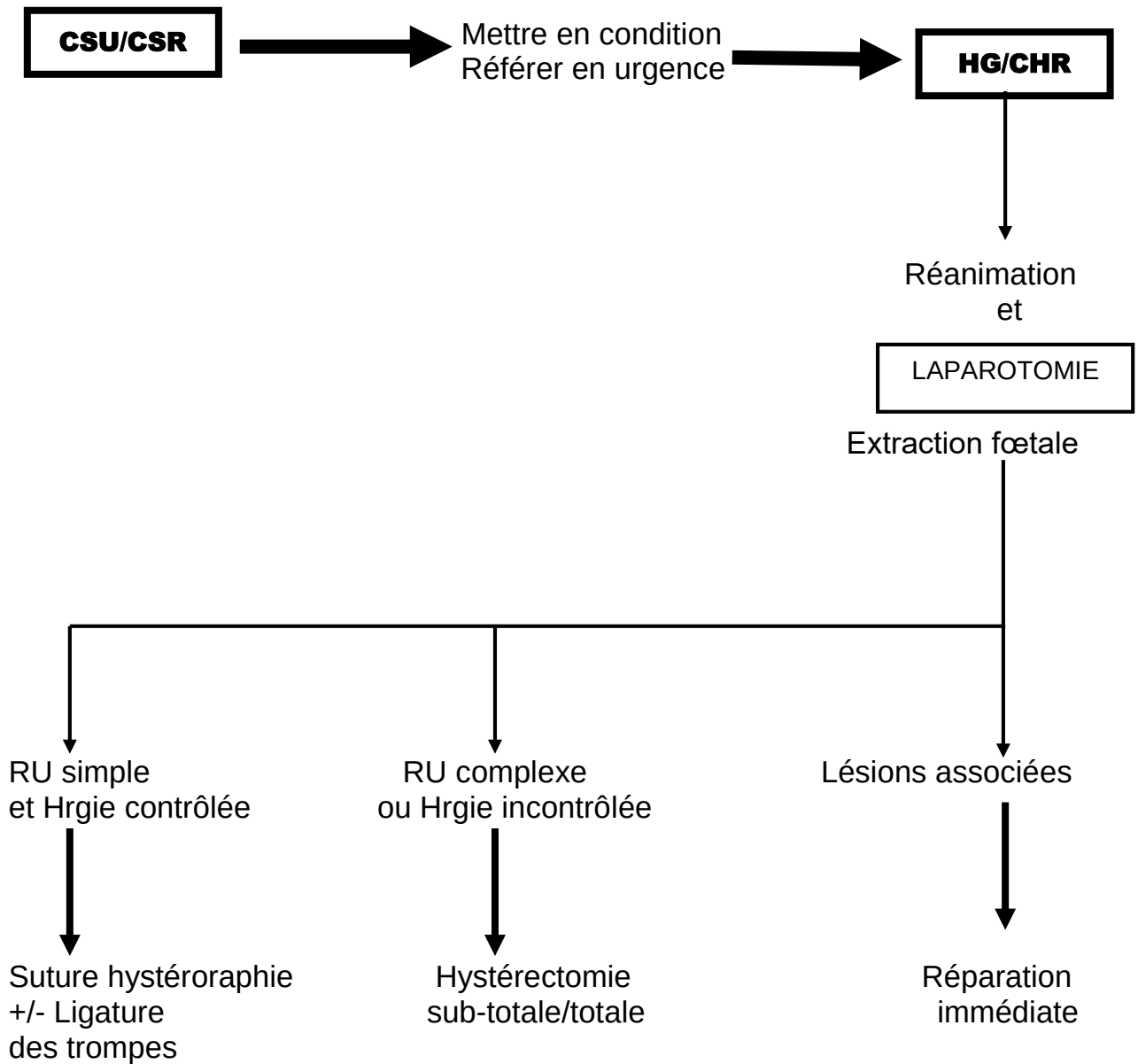
CAT DEVANT UN PACENTA PRAEVIA

HG/CHR

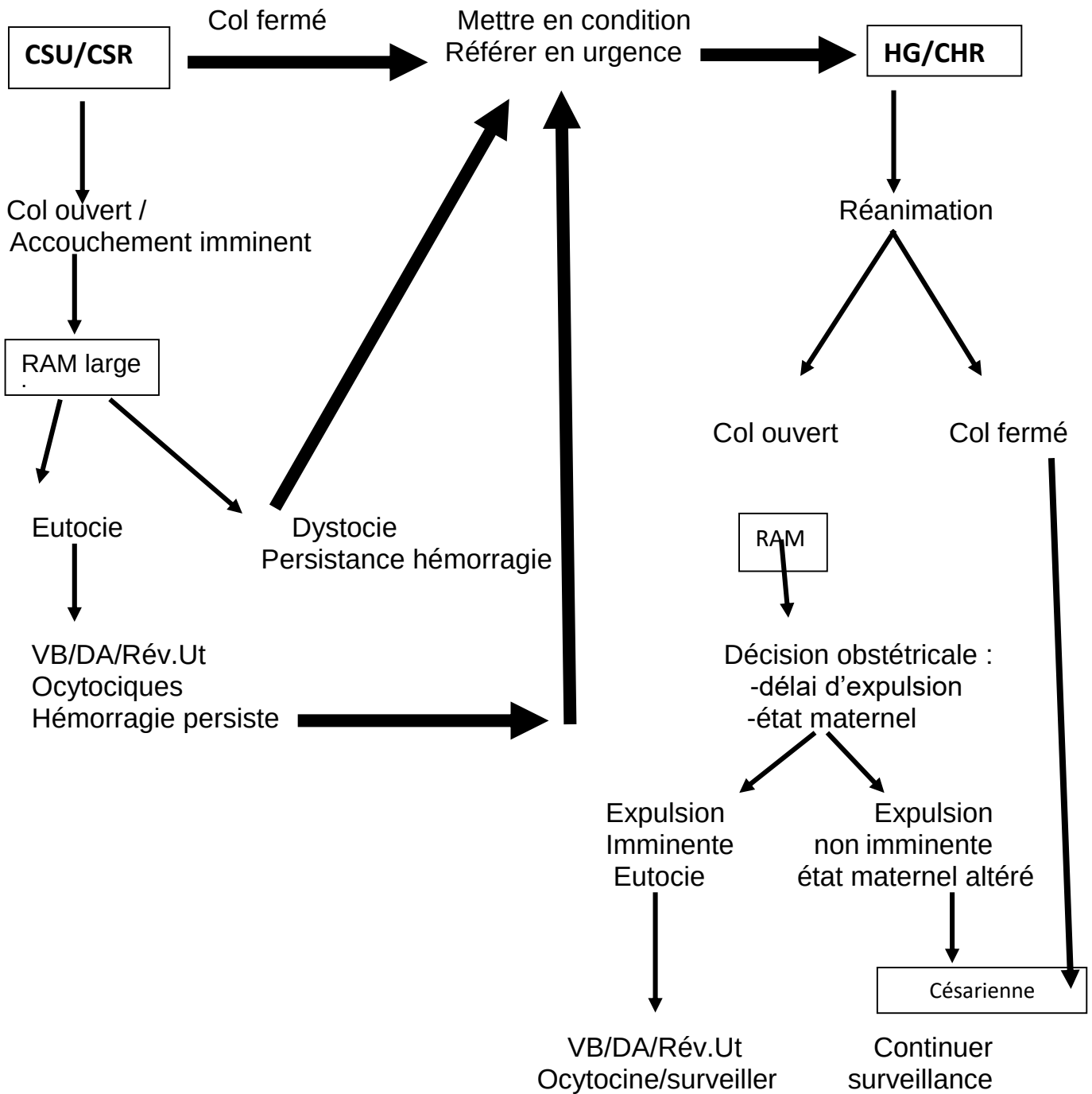
Réanimer selon l'état de la femme



CAT DEVANT UNE RUPTURE UTERINE

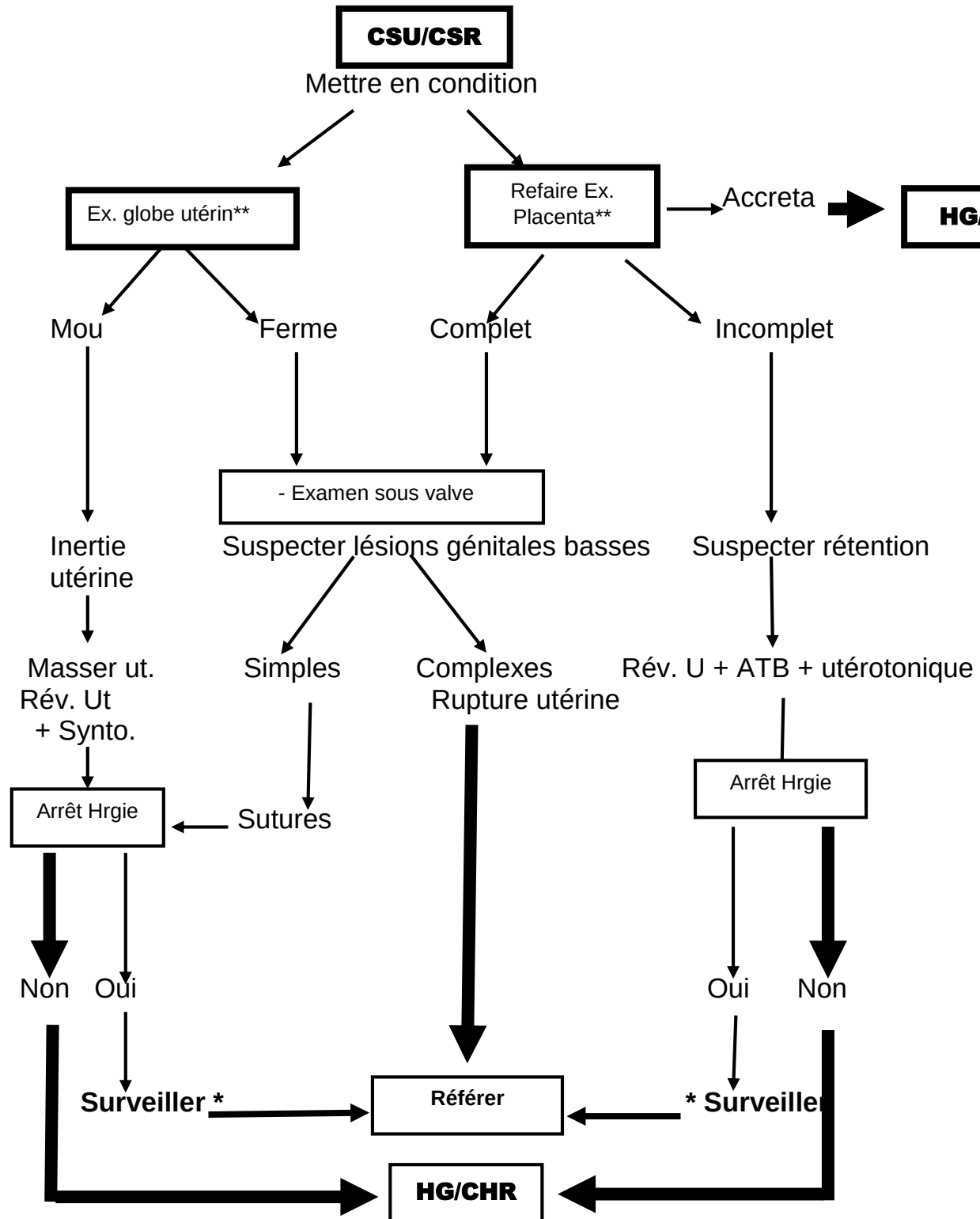


CAT DEVANT UN DECOLLEMENT PREMATURE D'UN PLACENTA NORMALEMENT INSERE (DPPNI)



Para clinique : TP, TCA, fibrinémie, NFS et plaquette, diurèse, échographie pelvienne

CAT DEVANT UNE HEMORRAGIE DU POST-PARTUM



* Référer au moindre problème.

** Examiner systématiquement quelle que soit la cause.